

CAPÍTULO 13.15

Neumonía atípica

PERFIL EUNACOM 1.04.1.016

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **neumonías virales**, también denominadas **neumonitis virales**, han cobrado una relevancia fundamental en la práctica clínica actual, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Aunque los virus respiratorios suelen limitarse a la vía aérea superior, ciertos agentes y contextos del huésped facilitan la progresión hacia el parénquima pulmonar, generando cuadros de insuficiencia respiratoria grave.

Etiología y Epidemiología

Los agentes causales varían significativamente según el grupo etario y el estado inmunológico del paciente:

TABLA 13.15.1: VIRUS VS POBLACIÓN DE RIESGO / CONTEXTO

VIRUS	POBLACIÓN DE RIESGO / CONTEXTO
SARS-CoV-2 (COVID-19)	Causa más frecuente de neumonía viral grave en adultos en años recientes.
Influenza (A y B)	Causa clásica de neumonía viral primaria y sobreinfección bacteriana.
Virus Respiratorio Sincicial (VRS)	Muy frecuente en niños menores de 1 año.
Adenovirus / Metaneovirus	Frecuentes en pediatría y brotes institucionales.
Virus Varicela-Zóster (VVZ)	Complicación grave en embarazadas y pacientes con Infección por VIH/SIDA o inmunocomprometidos.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: A diferencia de la neumonía bacteriana (que suele causar una respuesta alveolar localizada o lobar), los virus inducen una inflamación del **intersticio** y las paredes alveolares de forma difusa, lo que explica el patrón radiológico intersticial y la frecuente afectación bilateral.

Cuadro Clínico

El diagnóstico clínico se basa en la progresión de síntomas respiratorios. Habitualmente, el cuadro presenta dos fases:

- **Pródromo:** Inicia como una infección respiratoria alta (tos, coriza, odinofagia) o, en el caso de la varicela, con el exantema característico y fiebre.
- **Fase de Neumonitis:** Aparición de **disnea** y dificultad respiratoria.
- **Temporalidad:** *En la mayoría de los virus (como Influenza), la disnea aparece a los pocos días (3-4 días). Si la dificultad respiratoria aparece tardíamente (después de una semana de mejoría), se debe sospechar una **sobreinfección bacteriana**.*
- **Excepción:** En el caso de la COVID-19, la progresión a neumonía puede ocurrir incluso después de los 7 días del inicio de los síntomas.

Hallazgos al Examen Físico

Auscultación: Presencia de **crépitos** (estertores) finos. **Ausencia de condensación:** A diferencia de la neumonía por *Streptococcus pneumoniae*, no suele haber matidez ni soplo tubario localizado, ya que la afectación es difusa. **Compromiso Sistémico:** Taquipnea y desaturación arterial frecuente.

Diagnóstico y Exámenes Complementarios

En pacientes con criterios de hospitalización o gravedad, es imperativo identificar el agente etiológico.

Laboratorio Viral: Se solicita **Panel Viral** (Inmunofluorescencia indirecta o PCR multipanel) o PCR específica para SARS-CoV-2. Es fundamental para definir el uso de antivirales específicos. **Hemograma:** *Típicamente muestra **linfocitosis** (característico de infecciones virales), a diferencia*

de la neutrofilia con desviación a la izquierda de las bacterianas.
Imagenología: Radiografía de Tórax: Muestra un **patrón intersticial bilateral difuso**. **Tomografía Computarizada (TAC):** En COVID-19 es clásico el patrón de **vidrio esmerilado** (ground-glass) multifocal y periférico, o el patrón en **empedrado** (crazy paving).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si un paciente con Varicela presenta disnea, se debe sospechar de inmediato una neumonía viral por VVZ, especialmente si es una paciente embarazada. Es una urgencia médica que requiere hospitalización.

Manejo y Soporte Respiratorio

El pilar del tratamiento es el soporte de la **Insuficiencia Respiratoria**. El manejo de la oxigenoterapia debe ser escalonado según la gravedad del paciente:

- **Oxigenoterapia convencional:** Naricera o mascarilla simple (objetivo saturación >93%).
- **Mascarilla de alto flujo/recirculación.**
- **Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF):** Utilizada para evitar la ventilación mecánica.
- **Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI).**
- **Ventilación Mecánica Invasiva (VMI):** Intubación orotraqueal en caso de fracaso de medidas previas o compromiso de conciencia.
- **ECMO (Membrana de oxigenación extracorpórea):** Última línea de soporte.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Happy Hypoxemia (Hipoxemia Feliz): En pacientes con COVID-19, se observó que algunos mantenían buena mecánica respiratoria a pesar de saturaciones muy bajas. **La clínica manda:** No se debe intubar a un paciente que está clínicamente estable solo por un número en el oxímetro; se prefiere el uso de **posición prono** (decúbito ventral) para mejorar la ventilación/perfusión.

Tratamiento Farmacológico Específico

TABLA 13.15.2: PATOLOGÍA VS TRATAMIENTO DE ELECCIÓN

PATOLOGÍA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	CONSIDERACIONES
Influenza	Oseltamivir (EV/VO)	Alternativas: Zanamivir o Peramivir.
Varicela	Aciclovir (EV)	Siempre vía endovenosa en caso de neumonía.
COVID-19	Dexametasona (EV)	Reduce mortalidad. Se añade Heparina de bajo peso molecular (profilaxis de Tromboembolismo Pulmonar).
COVID-19 (Avanzado)	Remdesivir / Tocilizumab	Según disponibilidad y gravedad del cuadro.

Uso de Antibióticos

Aunque el cuadro es viral, en la práctica clínica se suele iniciar cobertura antibiótica empírica debido al alto riesgo de **sobreinfección bacteriana** o la dificultad inicial para diferenciarla de una neumonía bacteriana típica.

Esquemas habituales: Ceftriaxona, Cefotaximo, Ampicilina/Sulbactam o Levofloxacin (igual que en la **Neumonía Adquirida en la Comunidad hospitalizada**). **Neumonía Intrahospitalaria:** Si el paciente lleva tiempo hospitalizado y presenta un nuevo deterioro (fiebre, aumento de

parámetros inflamatorios), se debe escalar la cobertura para cubrir gérmenes nosocomiales.

EUNACOM CRITERIOS

Todo paciente con neumonía viral que requiera hospitalización debe permanecer bajo **aislamiento respiratorio** (aerosoles) o, como mínimo, aislamiento por gotitas, para evitar brotes intrahospitalarios.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Adolescente de 16 años consulta por tos persistente de 15 días de evolución que inició como cuadro gripal. Al examen presenta crepitaciones bilaterales y sibilancias difusas, sin foco de condensación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Neumonía atípica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los agentes atípicos son *Mycoplasma pneumoniae* (más frecuente), *Chlamydia pneumoniae* y *Legionella pneumophila*
- Los betalactámicos no tienen efecto sobre gérmenes atípicos; el tratamiento de elección son los macrólidos
- Alternativas terapéuticas: quinolonas respiratorias (levofloxacino, moxifloxacino) y doxiciclina
- Cuadro clínico arrastrado de más de 7 días, habitualmente 14-20 días al momento de consulta
- Afecta principalmente a niños y adolescentes; raro en mayores de 30 años
- Inicia como infección viral y evoluciona con tos intensa, luego disnea
- Al examen físico: crepitaciones bilaterales difusas con sibilancias, sin foco de condensación
- Radiografía: patrón alvéolo-intersticial bilateral con engrosamiento peribronquial, mayor en bases
- Manifestaciones extrapulmonares: eritema multiforme menor, síndrome hemolítico urémico, miringitis bulosa

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEUMONÍA ATÍPICA)**PREGUNTA 1**

Adolescente de 16 años consulta por tos persistente de 15 días de evolución que inició como cuadro gripal. Al examen presenta crepitaciones bilaterales y sibilancias difusas, sin foco de condensación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Neumonía adquirida en la comunidad por neumococo
- B)** Neumonía atípica por *Mycoplasma pneumoniae*
- C)** Crisis asmática
- D)** Bronquitis aguda viral
- E)** Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la neumonía atípica por *Mycoplasma*?

- A)** Amoxicilina/ácido clavulánico
- B)** Ceftriaxona endovenosa
- C)** Azitromicina
- D)** Cotrimoxazol
- E)** Imipenem

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes manifestaciones extrapulmonares se asocia a la infección por *Mycoplasma pneumoniae*?

- A)** Eritema nodoso
- B)** Eritema multiforme menor
- C)** Pioderma gangrenoso
- D)** Livedo reticularis
- E)** Psoriasis en gotas

RESUMEN: NEUMONÍA ATÍPICA

Las neumonías atípicas son causadas por microorganismos atípicos: *Mycoplasma pneumoniae* (el más frecuente), *Chlamydia pneumoniae* y *Legionella pneumophila*. Estos gérmenes no están cubiertos por betalactámicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos), por lo que el tratamiento de elección son los macrólidos, con alternativas como quinolonas respiratorias (levofloxacino, moxifloxacino) y tetraciclinas (doxiciclina). La presentación clínica típica de las neumonías atípicas es un cuadro arrastrado de más de 7 días, habitualmente 14 a 20 días al momento de consulta. Inicia como una infección viral indistinguible, afectando mayoritariamente a niños y adolescentes (raro en mayores de 30 años). Posteriormente evoluciona con tos persistente intensa, que puede desencadenar asma en susceptibles, y luego aparece disnea de esfuerzos. Al examen físico no hay foco neumónico de condensación, sino crepitaciones bilaterales difusas con componente obstructivo (sibilancias). En la radiografía se observa un patrón alvéolo-intersticial con engrosamiento peribronquial, bilateral y de predominio basal. Se asocian manifestaciones extrapulmonares como eritema multiforme menor, síndrome hemolítico urémico y miringitis bulosa (vesículas en tímpano). La clave diagnóstica es diferenciarla de las neumonías típicas (más agudas, con condensación focal) y de las infecciones respiratorias altas (sin síntomas bajos).